

针对性护理干预在子宫肌瘤围手术期的效果探讨

朱芳莉

睢宁县中医院，江苏 睢宁 221200

摘要: **目的** 研究子宫肌瘤患者中采取针对性护理干预时的效果。 **方法** 纳入我院2019年7月~2021年7月期间收治的50例子宫肌瘤患者，按照随机方式均分为I组和II组，II组采取常规护理，I组采取针对性护理干预，比较两组满意率，及护理前后的生活质量与护理效果。 **结果** I组满意率为100.00%，高于II组的80.00%，差异有统计学意义（ $P<0.05$ ）。两组护理前生活质量指标无统计学差异（ $P>0.05$ ），护理后差异有统计学意义（ $P<0.05$ ）。I组的肠功能恢复时间、住院时间、下床时间低于II组，差异有统计学意义（ $P<0.05$ ）。 **结论** 子宫肌瘤患者在采取针对性护理干预时，可显著提升满意率与生活质量，缩短住院时间，有应用价值。

关键词: 针对性护理干预；子宫肌瘤；生活质量

随着当前科技水平的高速发展，广大居民对于自身健康的认知水平和维护意识也在逐年提升^[1]。以女性患者为例，对于子宫肌瘤的重视程度也在逐年提升。通常而言，在女性中，子宫肌瘤作为十分常见的一项恶性肿瘤，当前在治疗方式的选择上主要以手术为主，其中子宫肌瘤切除术便能有效切除子宫肌瘤，整体的治疗效果显著。由于此病在中年妇女中发病率长期以来居高不下，而且近年来整体的发病率有上升趋势^[2]。从发病原因来分析，此病主要和女性性激素水平紊乱有关，其中肌瘤组织尤其对于雌激素的敏感性较高，而且也容易造成肌瘤发生。在临床中，一般子宫肌瘤患者较轻时通常无明显症状，所以很多患者延误就诊，严重时常以白带增多、月经紊乱为主，甚至也有部分患者会伴有腰背疼痛等，病程较长时甚至会发生贫血，对于他们的生活质量水平造成的影响极大。除此之外，子宫肌瘤通常和卵巢病变等妇科疾病合并发生，当恶性变化时，极有可能诱发宫颈癌，所以有必要引起广大居民的重视^[3]。尤其在选择手术治疗时，虽然能够较好的控制病情，但是合理的护理措施往往能够提高整体的治疗效果；尤其在围术期间，选择合理的护理措施至关重要，不但能够降低患者的疼痛感，同时也能够提高其康复水平，对于降低整体的医患纠纷具有十分重要的意义。此次研究重点

对针对性护理展开研究，从而讨论该措施在子宫肌瘤围术期中的应用效果，现报告如下。

一、资料与方法

（一）一般资料

2019年7月~2021年7月期间收治的50例子宫肌瘤患者，以随机掷骰子法均分为I组和II组。I组年龄36~59岁，平均 (46.32 ± 1.84) 岁，病程2~13年，平均病程 (7.14 ± 3.36) 年；II组年龄35~58岁，平均 (46.41 ± 1.43) 岁，病程2~12年，平均病程 (7.22 ± 3.41) 年。比较以上所列举的一般资料，无统计学差异（ $P > 0.05$ ）。

纳入标准：参选的对象均确诊为子宫肌瘤；具备自主能力的患者；知情研究内容且签订同意书；经我院医学伦理会批准。

排除标准：合并严重脏器类疾病；患有精神类疾病存在暴力倾向；反对此次研究；已纳入其他研究项目。

（二）方法

II组选择常规护理，主要内容为环境护理、心理干预以及基础的健康教育等。

I组则采取针对性护理，具体内容为：（1）入院护理。首先在住院时应当对患者的病情进行详细观察，一方面需要了解患者的月经改变情况，除此之外也需要了解既往史，并根据不同患者的实际病况来制定针对性的护理措施，同时根据患者的营养状况来安排合理饮食，并记录其生命体征，做好动态的书面记录，安排患者签署相关的责任文件书。次日晨起抽取空腹血，并安排患者进一步展开检查，同时与患者沟通时，也需要为其讲解医院的环境制度，当然也可以对医患间的状况加以更好地沟通，说明当前所存在的问题，以稳定其情绪。（1）术前准备。在手术开始前护理人员需要与患者加强沟通和交流，重点引导患者表达内心疑惑，由于很多患者在手术治疗前普遍担心治疗结果，所以在沟通过程中需要重点对本次治疗方案的优点展开说明，提高患者的信任度。除此之外，也需要针对患者的焦虑烦躁心理进行合理引导，例如引导期倾诉护理人员耐心倾听，充分尊重患者的个人情绪，使情感可以发现和流露，这对于缓解负性情绪而言具有

至关重要的作用。（2）术中护理。手术室护理人员应当提前半小时进入室内，做好手术器械的准备，将室内温度控制在 24℃，湿度控制在 60%。为了防止体温过低诱发感染，对手术所用输液液体提前进行加温，并对患者非施术部分加盖毛毯保暖。当医生在打开产妇的腹腔后，器械护士应当根据医师的操作进行预见性地传递手术器械，保证医师手术操作可以在最短时间内完成。（3）术后护理。患者在完成手术后，结合其情况来调整护理等级，饮食方面应该禁食水，并安排低流量吸氧对其生命体征加以监测。再者，应观察患者术区情况，如辅料、渗液等，关注患者疼痛感，予以缓解。应当第一时间和护理人员以及医师沟通，同时予以协商，例如对患者的体位加以改变，并保持腹部无重力状态，这对于缓解术后的疼痛具有至关重要的作用。在手术结束后的第 1 天，需要根据不同患者的康复情况来酌情变更护理等级，同时对于他们的体征指标做好动态的书面记录和观察，对于留置尿管和引流管的患者，也需要重点对导管展开护理，例如观察引流液的颜色、性质以及量，同时明确引流管接口部位是否有液体渗出，观察患者的阴道是否有流血，并对颜色和血量进行动态记录，出现异常时及时告知医师，当然对于患者的出现疼痛情况、生命体征等也必须做好记录和观察。另外鼓励患者多展开床上的运动，将手术后应当做的各项康复动作以及流程，尽可能耐心细致的为患者讲解说明。在术后第 2~3 天，需要对患者进行普外常规护理，观察其体征情况，尤其对于引流液的颜色量性质予以观察，并根据医嘱及时取下，日常在更换辅料时，需要对患者的创口情况进行清洁，情况允许时，也应该鼓励其下床，这对于促进排气具有积极意义。另外基于中医理念，选择耳穴埋籽，可以选择探棒进行试探按压，按压部位为阳性反应点，若按压时患者有明显的变化，则应取做耳穴埋籽点，取穴神门、交感、内分泌、大肠、小肠，促进肠胃功能恢复。

（三）观察指标

（1）满意率指标为满意：患者和护理人员沟通密切，完全遵照其指令；良好：患者对护理人员的指令配合度高，基本无异议；一般：大部分情况下可以遵照护理人员云安排；不满意：与护理人员出现冲突，或存在不听从安排的现象。

（2）护理前后以 SF-36 量表对比患者的生活质量，内容为心理、肢体、饮食、角色，各项满分 25 分，得分越高质量越优。

（3）护理效果评价标准患者术后的肠功能恢复时间、住院时间和下床活动时间。

(四) 统计学分析

以 SPSS20 处理，满意率以[n(%)]表示，行 χ^2 检验；生活质量、护理效果以 $(\bar{x} \pm s)$ 表示，行 t 检验。（ $P < 0.05$ ）时有统计学意义。

二、结果

(一) 满意率对比

I 组满意率为 100.00%，高于 II 组的 80.00%，差异有统计学意义（ $P < 0.05$ ）。见表 1。

表 1 满意率对比（ χ^2 ，%）

组别	n	满意	良好	一般	不满意	满意率
I 组	25	13(52.00)	7 (28.00)	5 (20.00)	0 (0.00)	25(100.00)
II 组	25	10(40.00)	8 (32.00)	2 (8.00)	5 (20.00)	20 (80.00)
χ^2	/	2.963	0.254	1.860	4.938	4.938
P	/	0.085	0.614	0.173	0.026	0.026

(二) 护理前后的生活质量对比

两组护理前生活质量指标无统计学差异（ $P > 0.05$ ），护理后差异有统计学意义（ $P < 0.05$ ）。见表 2。

表 2 护理前后的生活质量对比（ $\bar{x} \pm s$ ，分）

组别	n	心理		肢体		饮食		角色	
		护理前	护理后	护理前	护理后	护理前	护理后	护理前	护理后
I 组	25	17.52	23.47	16.2	22.32	17.32	23.23	18.21	23.63
		$\pm$	$\pm$	4 $\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$
		2.41	1.21	1.14	2.47	2.21	1.57	1.85	1.54
II 组	25	17.61	20.47	16.3	19.24	17.74	19.27	18.52	20.61
		$\pm$	$\pm$	5 $\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$
		2.21	2.32	1.42	2.23	2.47	1.34	1.74	1.23

<i>T</i>	/	0.138	5.733	0.30 2	4.628	0.634	9.593	0.610	7.661
<i>P</i>	/	0.891	0.000	0.76 4	0.000	0.529	0.000	0.545	0.000

（三）两组患者的恢复时间对比

I 组的肠功能恢复时间、住院时间、下床时间低于 II 组，差异有统计学意义（*P*<0.05）。见表 3。

表 3 两组患者的恢复时间（ $\bar{x}\pm s$ ）

组别	n	肠功能恢复时间 (h)	住院时间 (d)	下床时间 (h)
I 组	25	29.52±5.54	6.32±1.23	31.32±3.41
II 组	25	73.21±11.24	9.21±1.57	39.41±4.23
<i>t</i>	/	67.563	8.654	14.050
<i>P</i>	/	0.000	0.000	0.000

三、讨论

子宫肌瘤在女性人群中多为十分常见的一项良性肿瘤，大约占有良性肿瘤的 51.87%，而此病长期以来在临床中具有较高的发病率，尤其在我国整体的发病率高达 0.4~0.8%^[5]。尤其近年来随着妇女健康普查的广泛开展，再加上 B 超的应用，使得此病即便缺乏明显临床症状或肌瘤体积较小时，仍然能够得以发现。不过很多患者由于病情初期时无明显影响，所以很难及时就医，长此以往会诱发一系列临床症状，最终影响其身心健康^[6]。由此可见，选择合理的子宫肌瘤治疗措施，仍是当前临床中重点需要解决的难题，而针对子宫肌瘤的治疗不能选择单一的治疗方式，而需要根据患者的具体年龄、生育要求、肌瘤大小、位置等各方面因素来展开治疗，从而提高治疗的个性化和疗效。目前在子宫肌瘤的治疗措施选择上，主要以手术为主，虽然在选择合理的手术治疗时，能够有效的清除病灶，然而手术结束后仍然容易诱发诸多并发症，例如出血、穿刺孔损伤、瘤腔内血肿等^[7]。所以在整个围术期间，选择合理的护理干预措施至关重要，对于整体疗效的提升具有显著作用。

总体而言，子宫肌瘤在育龄期女性中的发病率高达 20%~25%，其病因在当前

临床中仍然缺乏统一定论，但很多学者认为此病通常和性激素水平、生长因子、免疫细胞遗传等因素有密不可分的关联。在选择腹腔镜手术治疗子宫肌瘤时，由于这项技术作为微创手术，在实际操作时可以降低对女性的创伤，同时术后不容易诱发并发症，且康复更加迅速，所以近年来应用愈发广泛。而腹腔镜手术可包括腹腔镜下子宫肌瘤剔除术以及全切术等。考虑到近年来广大居民对于自身健康的要求逐渐提高，同时大家对于医学观念也发生了巨大改变，很多子宫肌瘤患者平常仍然有生育的需求，所以在手术方案的选择上必须考虑到患者的个人诉求，也因此对于手术疗效的要求更高，对于安全性也提出了更高的考验。在郑红等人的研究中进一步指出，子宫肌瘤患者如果在进行手术时若合并妊娠，那么手术措施不当很可能导致子宫破裂。另外在杨小燕等人的研究中还指出，选择子宫肌瘤腹腔镜手术治疗时，可诱发的并发症，主要包括出血气肿、生殖系统损伤等，同时诸多并发症也有复发的可能。由此可见，针对子宫肌瘤患者而言，为其提供全面细致的围术期护理模式，不仅仅在于提高整体的手术效果，与此同时也能够使手术的安全性得以保障，对于患者后续的康复具有积极的促进意义。

针对性护理理念这一概念自引入我国以来，现今已逐渐在临床推广，而且相关研究也证实了，这一护理模式可以有效提高院内的护理质量，也能够极大缩短住院时间，对于降低医疗费用也有着较高帮助。作为当前新型的护理管理理念，针对性护理模式，在应用过程中针对围术期患者可以制定更符合需求的护理方案，并为他们提供专业的护理服务，可以有效使医院的管理者、医护人员、患者之间的关系更加紧密，对于提高最终的护理质量十分很重要。而近年来，临床护理路径逐渐被广泛应用于妇科疾病中，整体的护理成效显著，尤其对于患者的并发症预防以及情绪缓解具有至关重要的作用。

在子宫肌瘤患者为属性护理中，应用针对性护理模式时，患者在入院之初，护理人员首先应当了解其全面的个人信息资料，针对社会、心理、生理等多项信息进行汇总整理，并且展开专业的各项检测，如血、尿、生化等指标，然后对不同患者的手术适应症进行评估，然后调整患者的状态，处于舒适状态。与此同时，也要和患者制定相关的诊疗服务计划，并告知他们子宫肌瘤手术过程中应当注意的各类事项，同时对于安全性加以说明。在用餐方面应当要求清淡、容易消化。与此同时也需要安抚患者的情绪，耐心为他们解答疑惑并介绍术前的各项注意事

项,对于手术的环境麻醉等相关知识进行说明,这样能够有效提高整体的手术配合度。杜润清等人在研究中指出,对子宫肌瘤患者实施针对性护理,发现在护理结束后,患者的住院时间得到明显缩短。在此次研究中也可以看出,I组的肠功能恢复时间、住院时间、下床时间低于II组,差异有统计学意义($P<0.05$)。所以选择针对性护理模式是对于患者的康复有促进作出。完成手术的24小时内,给予患者流质饮食,同时防止牛奶、甜食等易产生气体的食物,直到患者自然通气,后方可基于普食。饮食的选择主要以营养丰富、易消化、清淡食物为主,同时在术后也鼓励患者适当的展开翻身。例如在术后第1天时便指导患者在床上进行活动,这样有利于促进胃部蠕动,防止肠梗阻常锻炼的并发症发生,同时观察患者置管,定期更换衣物。对于术后出现了疼痛,做好及时的疏导,可以使患者的整体生活质量得到提升,在本次研究中也可以看出,I组满意率为100.00%,高于II组的80.00%,差异有统计学意义($P<0.05$)。两组护理前生活质量指标无统计学差异($P>0.05$),护理后差异有统计学意义($P<0.05$)。

综上,当前在临床中针对子宫肌瘤患者的治疗,主要以手术为主而选择合理的手术措施能够有效清除病灶。同时在微创技术的不断应用下,可以有效降低手术的并发症。不过考虑到针对性护理模式属于一种新型的护理,在我国起步相对较晚,而在子宫肌瘤围术期护理中尚未得到大面积的推广,所以在后续研究中应当进一步展开大量的临床实践,使这一护理模式发挥更高价值。

参考文献

- [1] 王晓芳,杨红,吴蕾.扁平化责任制护理干预对腹腔镜子宫肌瘤剔除术患者胃肠功能恢复,护理质量及满意度的影响[J].中国性科学,2020,29(4):4.
- [2] 张鲜芳,张淑林,康小琴,等.临床护理路径在子宫肌瘤围手术护理中的应用效果[J].山西医药杂志,2019,48(12):3.
- [3] 张春花、邓艳辉、刘艳.综合专案护理结合Hogan理论对子宫肌瘤患者术后恢复及胃肠功能的影响[J].海军医学杂志,2020,41(6):4.
- [4] 程东方.扁平化责任制护理干预在腹腔镜子宫肌瘤剔除术中的应用效果分析[J].中国药物与临床,2021,21(10):3.
- [5] 裴晶.心理护理联合疼痛护理对子宫肌瘤患者的应用效果分析[J].中国药物与临床,2021,21(11):2.

[6] 闫永仁, 回淑莲, 王琼. 综合康复护理配合系统性健康教育对子宫肌瘤手术患者的影响[J]. 实用临床医药杂志, 2018, 022(014):90-93.

[7] 姚玥, 张烨. 快速康复护理在子宫肌瘤剔除术围术期病人中的应用效果[J]. 护理研究, 2021, 35(20):2.